

Plan *gotowy przed kryzysem*

Pisemny algorytm dla momentu, gdy impuls jest silny ($SUDS > 6$). W kryzysie mózg **NIE** myśli jasno — musi być gotowa lista. Osobisty, stworzony **PRZED** kryzysem. Na telefonie + na lodówce.

CZAS: 30 min · stworzenie planu · Sesja 3-4 CBT-E · po dzienniku i 3+2

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008); Marlatt & Gordon (1985)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **zasadę gotowego planu** (sekcja 1), **sześć elementów** (sekcja 2). Sekcja 3 — karta kieszonkowa. Sekcja 4 — przegląd tygodniowy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Plan awaryjny — **konkretny, spisany algorytm** dla momentu, gdy impuls epizodu jest silny ($SUDS > 6$). Kluczowa zasada: **w kryzysie mózg nie myśli jasno** — nie wymyślisz wtedy dobrej strategii. Musi być *gotowa lista*. Plan **osobisty**, stworzony *przed* kryzysem. Zawiera: **5 osób, 5 aktywności, 3 myśli wsparcia**. Na telefonie i na lodówce. Fairburn (2008): *written action plan*. Marlatt & Gordon (1985): pisemny plan redukuje nawroty o **30-40%**. Safer i in. (2009): element *distress tolerance*. Mechanizm: planowanie wcześniej → automatyzacja w kryzysie. Aktualizacja co 4-6 tyg.

01 ● Zasada — gotowy plan przed kryzysem

W kryzysie: mózg w trybie alarmu → kora przedczołowa „offline” → brak dostępu do strategii → tylko *znana droga* (epizod) → działanie zanim świadomość zdąży reagować.

Z planem: sięgnięcie po kartę → konkretne kroki gotowe → *automatyczne* wykonanie pierwszego kroku (telefon, prysznic, oddech) → przerwanie *cognitive narrowing* → kora przedczołowa wraca → możliwość wyboru.

Klucz: plan jest *protezą* dla mózgu w kryzysie. Bez planu pierwszy krok wymaga refleksji, której w kryzysie nie ma. Z planem pierwszy krok wymaga tylko *sięgnięcia* po kartę.

02 = Sześć elementów planu awaryjnego

1 · 5 OSÓB DO ZADZWONIENIA

Konkretne imiona + numery: terapeuta, bliscy, przyjaciel. Sprawdzeni, dostępni. Kolejność od „najłatwiejsze” do „najbardziej intensywnie”.

2 · 5 AKTYWNOŚCI ALTERNATYWNYCH

Surfowanie po impulsie (*urge surfing*), spacer, gorący prysznic, telefon, dziennik. Konkretne, dostępne. *Bez kompensacji*.

3 · 3 MYŚLI WSPARCIA

„Ten impuls przejdzie”, „Już przeszedłem wiele kryzysów”, „Mam wybór”. Twoje osobiste mantry.

4 · KARTA KIESZONKOWA

Wszystko na jednej karcie wielkości karty kredytowej, w portfelu / telefonie. Krótki tekst, czytelny w 30 sekund.

5 · NA LODÓWCE

Druga kopia widoczna w miejscu ryzyka — kuchnia, lodówka. „Zanim otworzysz lodówkę: zobacz tę kartę”.

6 · PRZEGLĄD CO TYDZIEŃ

Co tydzień (najlepiej z terapeutą): czy plan jest aktualny? Czy działał? Co dodać, usunąć, zmienić.

Wypełnij **swoimi danymi**. Konkretnie osoby, konkretne aktywności, konkretne myśli. Następnie **przepisz** na małą kartkę i noś w portfelu / telefonie.

PLAN AWARYJNY — GDY IMPULS > 6

Zadzwoń do (kolejno):

Zrób (jedna z aktywności):

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Pamiętaj (3 myśli wsparcia):

CZY PLAN DZIAŁAŁ W TYM TYGODNIU

— używałem/-am, co zadziało, czego brakowało, co zaktualizuję

Klucz: plan awaryjny jest *jedną z najprostszych*, ale jednocześnie **najsilniejszych** interwencji w profilaktyce nawrotów. Marlatt & Gordon (1985): w klasycznym *Relapse Prevention* dla uzależnień pisemny plan kryzysowy redukuje ryzyko nawrotu o **30-40%** w ciągu roku. Mechanizm: w kryzysie kora przedczołowa jest „offline” — nie generuje strategii. Pisemny plan jest *protezą* — daje gotowe pierwsze kroki, których nie trzeba wymyślać. Fairburn (2008) w CBT-E zaleca *written action plan* dla zagrożenia epizodem — wprowadzany w sesji 3-4, po dzienniku i regularnym jedzeniu. **Krytyczne:** plan musi być *fizycznie dostępny*. Plan „w głowie” w kryzysie nie działa — kryzys *uniemożliwia* dostęp do treści w głowie. Plan *na telefonie, na lodówce, w portfelu* działa, bo wymaga tylko *sięgnięcia*. Safer, Telch & Chen (2009) w DBT-BN integrują plan jako element *distress tolerance* — łączą go z TIPP, urge surfingiem i ACCEPTS. Plan *nie* jest jednorazowym narzędziem — wymaga *aktualizacji co 4-6 tygodni*. Zmieniają się osoby kontaktowe, aktywności, sytuacje życiowe. Nieaktualny plan działa gorzej niż brak planu — daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. **Regularny przegląd** (tygodniowy z terapeutą, comiesięczny samodzielnie) utrzymuje plan żywym.